

ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева"
Минздрава России
Адрес места нахождения и почтовый адрес:
117997, г. Москва, ул. Саморы Машела, д. 1
Тел.: (495) 287-65-70



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное учреждение
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ, ОНКОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ
ИМЕНИ ДМИТРИЯ РОГАЧЕВА»**

Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России)

3 АПР 2026

№ 1480

Москва

**ВЫПИСКА
ИЗ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ № 2026/4452**

Ф.И.О. пациента **БАРАХТЕНКО ЕГОР АНДРЕЕВИЧ**

Дата рожд. **24.04.2008**

Возраст **18 л.**

Пол: **Мужской**

Адрес регистрации: Российская Федерация, Саха /Якутия/ Респ., г. Якутск, III Сергеляхское
5 км д. 45 кв. 5А

Адрес проживания: Российская Федерация, Саха /Якутия/ Респ., г. Якутск, III Сергеляхское
5 км д. 45 кв. 5А

Находился в Отделение трансплантации гемопоэтических стволовых клеток №1 с
24.04.2026 по 03.05.2026

Клинический диагноз:

Основное: Миелодиспластический синдром с гиперэкспрессией WT1, мутация в гене NRAS от 21.11.24; первая алло-ТГСК (ПСКК) от неродственного ПЛА-идентичного донора от 01.04.25; первая клинико-гематологическая, молекулярная ремиссия от 29.04.25. Вторичный миелоидный лейкоз в исходе миелодиспластического синдрома от 03.07.25, внутреннее тандемное удвоение в гене FLT3 (FLT3/ITD), гиперэкспрессия гена WT1, BAALC; повторная алло-ТГСК от гаплоидентичного донора (отец) от 16.09.25; клинико-гематологическая, молекулярная ремиссия от 14.10.25; молекулярный рецидив (FLT3/ITD, гиперэкспрессия гена WT1, BAALC-39) от 13.11.25, персистенция МОБ (ИФТ) от 04.12.25; инфузия донорских лимфоцитов №1 (1,0x10⁵) от 08.12.25; костно-мозговой рецидив от 15.01.26. Введение анти CD33 CAR-NK лимфоцитов от 8.04.2026 от гаплоидентичного донора (отца). Прогрессия от 23.04.2026. (С92.0 Острый миелобластный лейкоз [ОМЛ])

Осложнение основного: Рецидив ТГСК (D84.8 Другие уточненные иммунодефицитные нарушения)

Осложнение основного: Рецидив ТГСК (Z94.8 Наличие других трансплантированных органов и тканей)

Осложнение основного: Индуцированная аплазия кроветворения (D70 Агранулоцитоз)

Сопутствующее: Аорто-мезентериальный конфликт слева (сдавление левой почечной вены). (N28.8 /Другие уточненные болезни почек и мочеточника)

Группа крови 0(I)Rh+ Дата определения 25.03.2026

Анамнез жизни: Ребенок от 1-ой беременности, 1-х родов. При рождении вес 3600г, рост 53 см. Выписан из р/д домой. Вакцинирован по нац. календарю до 16 лет, после ТГСК не вакцинирован. Перенесенные заболевания: ветряная оспа 2013г, пупочная грыжа 2016г (оперирован), ОРВИ 2-3Р/ГОД. Вросшие ногти 1-ых пальцев обоих стоп.

Семейный анамнез: Сиблинг девочка 2010г.р. - здорова. Единоутробная сестра 2024г.р. - здорова. По гематологическим и онкологическим заболеваниям неотягощен.

Аллергоанамнез: лактазная недостаточность ?

Операции и травмы: 2013г оперирован по поводу водянки оболочек яичек
2016г грыжесечение - пупочная грыжа, circumcision.
29.07.25г искректомия, околоногтевой паронихий.
13.03.26 выполнена пункция верхнечелюстных пазух с 2х сторон

Гемотрансфузионный анамнез: Трансфузии компонентами крови проводились, без осложнений

Анамнез заболевания: болен с сентября 2024 года, когда появились жалобы на слабость, быструю утомляемость; проведено обследование:

- гемограмма от 20.11.24: лейкоциты 12.9 тыс/мкл, гемоглобин 58 г/л, тромбоциты 37 тыс/мкл; бласты 3%.

- миелограмма от 21.11.24: по данным миелограммы отмечается гиперклеточный КМ с наличием бластных клеток от 11,4% до 13,8%. Эритропоэз с преобладанием нормобластического типа кроветворения с небольшим мегалобластическим компонентом, с признаками дисэритропоэза. Гранулоцитарный ряд сужен с проявлением признаков дисгранулопоэза. Мегакариоциты в небольшом количестве без видимой функциональной активности с признаками дисмегакариопоэза. Морфологическая картина костного мозга соответствует МДС, вариант ИБ II.

- ИФТ КМ от 21.11.24: выявлена популяция клеток низкой и промежуточной гранулярности и сниженным уровнем экспрессии общелейкоцитарного маркера CD45 и экспрессией CD34 (бласты 11%).

- трепанбиопсия КМ от 04.12.24: Морфологическая картина миелоидной неоплазии с резким расширением, омоложением и нарушением созревания гранулоцитарного ростка, с избытком CD34+ клеток и признаками дисплазии в мегакариоцитарном ростке.

- по результатам молекулярного исследования КМ выявлена мутация в гене NRAS (соматическая).

- по данным секвенирования ДНК (от 17.02.25): выявлен вариант нуклеотидной последовательности в экзоне 7/10 гена WT1 в гетерозиготном состоянии

Таким образом, по данным проведенного обследования отмечается течение миелодиспластического синдрома.

10.12.24 начата гипометилирующая терапия (азацитидин) в комбинации с венетоклаксом, на фоне проведения двух курсов терапии достигнута клинико-гематологическая ремиссия от 15.01.25, молекулярная ремиссия от 04.03.25.

01.04.25 выполнена алло-ТГСК от неродственного HLA-идентичного донора (ПСКК).

- Режим кондиционирования: бусульфан 12 мг/кг, флударабин 150 мг/м².

- Профилактика РТПХ: циклофосфамид в дни +3, +4, такролимус и микофенолата мофетил с +5 суток.

- Приживление трансплантата на 23-и сутки.

- Осложнения в раннем посттрансплантационном периоде: энтеропатия смешанного генеза, острый геморрагический цистит, мукозит оральный 2 степени, нейротоксическая реакция, токсический дерматит, острый периодонтит.

По результатам исследования костного мозга на +30-е сутки у пациента сохраняется полная клинико-гематологическая, молекулярная ремиссия основного заболевания.

На +92-е сутки от ТГСК (03.07.25): бластемия до 4 %, миелограмма (бласты 23,2%), метод ИФТ (бласты 11,4%), методом ПЦР (гиперэкспрессия генов BAALC, WT1).

Таким образом, по данным обследования у пациента констатирована трансформация в

острый миелоидный лейкоз в раннем посттрансплантационном периоде.

С 09.07.25 по 11.07.25 проведен блок FLA в комбинации с венетоклаксом с 12.07.25.

Осложнения:

- сепсис, септический шок.
- инфекции мягких тканей 1 пальца левой стопы (*Klebsiella pneumoniae*), выполнена некрэктомия тканей 1 пальца правой стопы.
- очаговая пневмония S6 правого легкого (+ галактоманнан)

На +118-е сутки от ТГСК (29.07.25):

- миелограмма: 70,6% бластов.
- молекулярно-биологическое исследование: выявлено внутреннее tandemное удвоение FLT3 (FLT3/ITD), гиперэкспрессия гена WT1, BAALC.

05.08.25 выполнена ЛП с интратекальным введением метотрексата и преднизолона, ликвор без особенностей.

Учитывая выраженный бластоз КМ, состояние после септического шока, появление в костном мозге мутации FLT3/ITD, инициирована трехкомпонентная терапия (5-азацитидин, венетоклак, гилтеритиниб).

- миелограмма (04.08.25): количество бластов не увеличено.

Учитывая диагноз, развитие рецидива заболевания после аллогенной ТГСК от неродственного донора, с целью достижения ремиссии заболевания принято решение о проведении повторной аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток от гаплоидентичного донора-отца.

16.09.25 выполнена повторная алло-ТГСК от гаплоидентичного донора (отца), источник трансплантата ПСКК.

- Режим кондиционирования: мелфалан 140 мг/м², флударабин 150 мг/м².
- Профилактика РТПХ: циклофосфамид, сиролимус, руколитиниб.
- Приживление трансплантата на 24-е сутки.
- Осложнения в раннем посттрансплантационном периоде: фебрильная нейтропения, правосторонняя верхнедолевая пневмония (*Enterococcus faecium*, EBV), геморрагический цистит, хронический сфеноидальный синусит

По результатам исследования костного мозга на +30-е сутки (14.10.25) достигнута полная ремиссия (в миелограмме количество бластов не увеличено; не обнаружены экспрессия гена BAALC, внутреннее tandemное удвоение FLT3 (FLT3/ITD), гиперэкспрессия гена WT1, гиперэкспрессия гена EVI1; ликвор интактен), химеризм полный донорский.

На + 58-е сутки от ТГСК (13.11.25): зафиксирован молекулярный рецидив основного заболевания (FLT3/ITD, гиперэкспрессия гена WT1). Химеризм >97%.

С целью достижения ремиссии основного заболевания проведена терапия гилтеритинибом с 20.11.25 по 04.12.25.

На +79-е сутки от ТГСК (04.12.25):

- миелограмма: КМ гипоклеточный, кол-во бластов не увеличено.
- ИФТ КМ: персистенция МОБ (5%), экспрессия CD117+.
- химеризм: со снижением до 80-89%.
- молекулярно-генетическое исследование: обнаружено внутреннее tandemное удвоение FLT3 (FLT3/ITD), гиперэкспрессия гена WT1.

Учитывая анамнез заболевания, развитие молекулярного рецидива, персистенцию МОБ (ИФТ) в ранние сроки после повторной алло-ТГСК, прогноз заболевания неблагоприятный. Принято решение о начале комбинированной терапии ингибиторами FLT3 (гилтеритиниб), ингибиторами BCL2 (венетоклак), гипометилирующими агентами (азацитидин), ингибитором тирозинкиназ второго поколения (дазатиниб).

08.12.25 выполнена инфузия донорских лимфоцитов №1 (1,0×10⁵).

С 09.12.25 по 15.12.25 курс гипометилирующей терапии (азациитидин).
С 15.12.25 по 22.12.25 курс терапии гилтеритинибом (80 мг/сут).
С 29.12.25 по 10.01.26 курс терапии венетоклаксом (100 мг/сут) (прерван в связи с развитием гематологической токсичности).
С 26.12.25 по 15.01.26 курс терапии дазатинибом (50 мг/сут)

На +121-е сутки от ПЧСК (15.01.26):

- гемограмма: бластемия 14%
 - миелограмма: бласты 27,8%, КМ гипоклеточный.
 - химеризм: снижение до 50-59%.
 - молекулярно-генетическое исследование: гиперэкспрессия гена WT1, BAALC-39, внутреннее тандемное удвоение FLT3 (FLT3/ITD).
 - ликворограмма: бластных клеток нет.
- Таким образом, зафиксирован костно-мозговой рецидив основного заболевания.

С учетом прогрессирования основного заболевания на фоне проводимой комплексной терапии, отсутствия альтернативных стандартных методов лечения, проведена ТМК в НМИЦ Д.Рогачева, принято решение о проведении НК-клеточной терапии, 16.02.26 выполнен лейкоферез у отца.

Со сдерживающей целью проводилась терапия в объеме:

- венетоклак (400 мг) с 15.01.26, со снижением до 200 мг с 02.02.26 по 12.02.26.
- цитарабин (50 мг/сут) с 24.01.26, 100 мг/м2 (суточная инфузия) с 29.01.26, с повышением дозы до 160 мг/м2 03.02.26 по 27.02.26.
- дазатиниб (70 мг/сут) с 29.01.26 по 13.02.26.
- азациитидин (75 мг/м2) с 21.01.26 по 28.01.26.
- даунорубин в/в 30.01.26.

На +156-е сутки от ПЧСК (19.02.26):

- миелограмма: бласты 18,4% (с уменьшением в динамике).
- химеризм: рост до 90 - 97%.
- молекулярно-генетическое исследование: гиперэкспрессия гена WT1 со снижением, гиперэкспрессия гена BAALC с увеличением, внутреннее тандемное удвоение FLT3 (FLT3/ITD) со снижением.

Осложнения на этапе терапии "сдерживания":

1. Мукозиг ЖКТ I степени.
 2. Двусторонняя пневмония (Asp. Ag., Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, CMV, EBV 15.01.26; EBV, HHV6, РС-вирус, риновирус, Candida, Staphylococcus haemolyticus, Leuconostoc lactis, AsAg6 27.02.26).
 - КТ ОГК от 15.01.26: КТ-признаки появления очагово-инфильтративных изменений в обоих легких.
 - КТ ОГК от 14.02.26: положительная динамика в виде регресса двусторонних очагово-инфильтративных изменений, в очаге в верхней доле правого легкого сформировалась полость.
 - КТ ОГК от 25.02.26: отрицательная динамика в виде появления свежих очаговых изменений по типу бронхоолита в нижней доле левого легкого.
 - КТ ОГК от 09.03.26: отрицательная динамика в виде билатеральных полисегментарных участков уплотнения легочной ткани, перибронхиальной диссеминации. КТ-признаки билатерального гидроторакса, гидроторакса, жидкость в брюшной полости.
 - КТ ОГК от 23.03.26: умеренная положительная динамика двусторонних очагово-инфильтративных изменений в легочной ткани.
 3. Полисинусит (Enterococcus faecalis, S - ванкомицин, линезолид, тигециклин по данным пункции ВЧП от 13.03.26).
 4. Двусторонний отит, перфоративный отит среднего уха.
- Проводилась комбинированная противомикробная терапия (цефотриаксон/ампициллин/сульбактам/меропенем, азтреонам, колистин, тигециклин, левофлоксацин, колмистин, метронидазол, амфотерицин В/вориконазол).

С 10.03.26 по 12.03.26 возобновлена терапия цитарабином в дозе 75 мг/м2/сут.

С 11.03.26 проводится терапия гилтеритинибом 120 мг/сут, с 13.03.26 - венетоклаксом 200

мг/сут.

25.03.2026 госпитализирован в боксированное отделение гематологии и детской онкологии первичная плановая для прохождения обследования перед проведением CAR-T- клеточной терапии и продолжения специфического лечения.

Состояние при поступлении тяжелое по основному заболеванию, а также за счет течения осложнений - двусторонняя полисегментарная пневмония (смешанного генеза), двусторонний гнойный средний отит, пансинусит (*Ent.faecium*) по данным выписки с места жительства, в связи с чем была инициирована противомикробная терапия в объеме - меронем, колистиметат, селезолид, амбизом в/в. Оценка статуса основного заболевания:

- Гемограмма от 25.03.26: лейкоциты 0,72 тыс/мкл, гемоглобин 99 г/л, тромбоциты 81 тыс/мкл, нейтрофилы 0,01 тыс/мкл.

- Лейкоформула от 25.03.26: с/я нейтрофилы 3%, лимфоциты 91%, моноциты 5%, миелоциты 1%

- Миелограмма от 26.03.26: бластные клетки 1 и 10%, все ростки костномозгового кроветворения редуцированы.

- ИФТ КМ от 26.03.26: опухолевая популяция 7,5%.

- ликворограмма от 26.03.26: цитоза, бластных клеток нет.

- ФА от 01.04.26: FLT3-ITD, составляющая 85 п.о.(Ratio=0,06).

Таким образом, сохраняется рецидив основного заболевания, наблюдается снижение бластоza в костном мозге (ранее 18,4% от 19.02.26). В рамках терапии "сдерживания" пациенту продолжена терапия венклекстой 200 мг/сут, а также FLT3-ингибитором гилтеритинибом (ксоспата) 120 мг/сут р.о. Учитывая рефрактерное течение вторичного острого миелоидного лейкоза на фоне проведенной ранее комплексной специфической терапии (в том числе повторная алло-ТГСК), отсутствие альтернативных стандартных методов лечения, пациенту планируется проведение анти-CD33 CAR-NK терапии.

30.03.26 без технических трудностей выполнена постановка двухканального ЦВК типа Broviack с целью обеспечения длительного венозного доступа.

Осложнения за период наблюдения: I.

Инфекционные:

1) Двусторонняя полисегментарная пневмония (РС-вирус, парагрипп) без проявлений дыхательной недостаточности: проводилась комбинированная противомикробная терапия (меронем, колистиметат, селезолид, амбизом в/в). По данным бронхоскопии с забором БАЛ от 27.03.26 выявлены Parainfluenzae virus III, РС-вирус, данных за течение грибковой и бактериальной инфекции не получено. Учитывая отсутствие данных за наличие грамотрицательной инфекции, стойкий афебрилитет, 31.03.26 отменен колистиметат, 01.04.26 меронем заменен на сульцеф; принимая во внимание отсутствие данных за течение грибковой инфекции, а также нарастание креатинина (максимально до 176 мкмоль/л), амбизом заменен на вифенд в/в.

2) Двусторонний гнойный средний отит, правосторонний перфоративный отит: проводилась комбинированная противомикробная, симптоматическая терапия. По данным микробиологического исследования отделяемого из правого уха м/о не выявлены.

3) Пансинусит (*Ent.faecium* по данным пункции ВЧП от 13.03.26): проводилась комбинированная противомикробная, симптоматическая терапия. II.

Неинфекционные: 1) Острое почечное повреждение - изолированное нарастание креатинина (максимально до 176 мкмоль/л, СКФ по цистатину С 68 мл/мин/м2): увеличена инфузионная терапия, проведена деэскалация противомикробной терапии (отменен амбизом), продолжено наблюдение в динамике.

2) Аплазия кроветворения, агранулоцитоз: проводилась заместительная гемотрансфузионная терапия по требованию.

По данным проведенного обследования абсолютных противопоказаний к проведению анти-CD33 CAR-NK терапии не выявлено.

3.04.2026 госпитализирован в отделение ТГСК1 для проведения CAR-NK клеточной терапии от гаплоидентичного донора (отца).

С 04.04.2026 по 06.04.2026 проведена лимфоденстирующая терапия:

- Флударабин 90 мг/м2 (СД 160 мг) с -4 по -2 дни

- Циклофосфан 750 мг/м2 (СД 1342 мг) на -2 день + урометексан (СД 2412 мг)

08.04.2026 введены анти-CD33 CAR-NK клетки от гаплоидентичного донора (отца);

Оценка статуса ремиссии:

15.04.2026 (+7 сутки):

- Миелограмма 30,4/40% бластных клеток

- MRD (ИФТ) 22,14% опухолевых клеток
- Персистенция анти- CD33 CAR-NK лимфоцитов кровь/КМ: 63,9% от 0,1 тыс/мл (NK) / 75,1% от 0,8 тыс/мл (NK)
23.04.2026(+14 сутки):

- Миелограмма 71/ 60,0% бластных клеток по точкам соответственно.

- MRD (ИФТ): опухолевая популяция 51,2 %; экспрессия CD33+ на 100% бластных клеток
- Персистенция анти- CD33 CAR-NK лимфоцитов: в КМ 35,2% от 0,1 тыс/мл NK- клеток; в периферической крови 40,4% от NK- клеток;

Таким образом, на + 14 сутки после введения анти- CD33 CAR-NK лимфоцитов у пациента имеет место прогрессия основного заболевания.

Осложнения за период наблюдения:

- Двусторонний гнойный средний отит, правосторонний перфоративный отит, затяжной риносинусит - проводилась комбинированная антибактериальная терапия, наблюдался отоларингологом, в динамике с улучшением, констатируется разрешение инфекционных очагов.

- Течение двусторонней полисегментарной пневмонии (РС-вирус, парагрипп) с положительной динамикой в виде улучшения аускультативной картины и рентгенологическим признакам организации очагов (МСКТ 15.04.2026).

- Острое почечное повреждение- положительная динамика в виде нормализации уровня креатинина и мочевины в плазме, восстановления скорости клубочковой фильтрации.

Вирусологический мониторинг в крови оставался отрицательным

Катетеры при поступлении: Центральный без тоннеля - 08.03.2026

Соматический статус при поступлении: Рост: 186,5, Вес: 59,6, S тела: 1,76, ЧСС: 80, ЧДД: 16, SpO2: 98, АД сист.: 115, АД диаст.: 78, t: 36,4

Жалобы: снижение слуха (перфорация барабанной перепонки справа 16.03.26), кашель с мокротой.

Состояние: тяжелое по заболеванию, а также за счет течения двусторонней очагово-инфильтративной пневмонии смешанного генеза по данным с м/ж, пансинусит, двусторонний гнойный средний отит.

Самочувствие: не нарушено.

Сознание: ясное.

Неврологический статус: без особенностей.

Положение: активное.

Эндокринная система: видимой патологии нет.

Телосложение: астеническое.

Кожные покровы: бледно-розовые, чистые, сухие. Геморрагический синдром не выражен. Тургор тканей достаточный. ПЖК развита слабо, распределена равномерно, видимых отеков нет.

Слизистые оболочки: Язык чистый, влажный. Слизистые чистые, бледно-розовые, влажные. Стенки зева не гиперемированы.

Костно-мышечная система: без патологических изменений, видимых костных деформаций нет.

Лимфатическая система: периферической лимфаденопатии нет.

Сердечно-сосудистая система: аускультативно тоны сердца ясные, ритмичные, патологических шумов не определяется. Нормотония.

Органы дыхания: Дыхание через нос умеренно затруднено, отделяемого нет. В легких аускультативно дыхание жесткое, равномерно проводится во все отделы, мелкопузырчатые хрипы по заднебазальным отделам легких. Кашель малопродуктивный, одышки при осмотре нет. SpO2 100%.

Пищеварительная система: пальпация органов брюшной полости безболезненна, живот при пальпации мягкий, глубокой пальпации доступен.

Селезенка: не пальпируется.

Печень: по краю реберной дуги.

Мочевыделительная система: мочеиспускание свободное, дизурии нет. Моча, со слов, светло-желтая, прозрачная.

Проведено лечение:

Противовирусная профилактика: Валацикловир (таб. 500 мг), 500 мг x 2 p/c per os, с

24.04.2026 по 3.05.2026

Противогрибковая профилактика: Вифенд 300 мг [за 1 час] в/в х2 р/с, с 24.04.2026 по 03.05.2026

Инфузионная терапия с 24.04.2026 по 03.05.2026

Противопневмоцистная профилактика: Ко-тримоксазол (табл. 480 мг), 3 табл. х 1 р/с per os, 24.04.2026, 27.04.2026, 29.04.2026

Сопроводительная терапия: Повидон-йод 10%, 1 раз х 6 р/с обработка, с 24.04.2026 по 03.05.2026; Фолиевая кислота (табл. 1 мг), 3 мг х 1 р/с per os, с 24.04.2026 по 03.05.2026;

Хлоргексидин 0.05%, 1 раз х 8 р/с местно, с 24.04.2026 по 03.05.2026; Ондансетрон 8 мг до 10 мл физ.р-ра в/в х3 р/с, с 24.04.2026 по 03.05.2026; Комфодерм К (крем), 1 раз х 4 р/с обработка, с 24.04.2026 по 03.05.2026; Леветирацетам (табл. 250 мг), 500 мг х 2 р/с per os, с 24.04.2026 по 03.05.2026; Викасол 1 мл до 20 мл физ.р-ра в/в, 24.04.2026; Бепантен (крем 5%), 1 раз х 4 р/с обработка, с 24.04.2026 по 03.05.2026; Аллопуринол (табл. 100 мг), 100 мг х 4 р/с per os, с 24.04.2026 по 03.05.2026;

Антибактериальная терапия: Селезолид 600 мг [за 1 час] в/в х2 р/с, с 24.04.2026 по 28.04.2026; Меронем 1.2 г до 20 мл физ.р-ра в/в х3 р/с, с 24.04.2026 по 03.05.2026;

Трансфузионная терапия: Тромбоцитный концентрат

Эритроцитная взвесь

Катетеры: Имплантируемый Хикман - 30.03.2026 (REF: 600570)

Динамика в стационаре: За период наблюдения состояние пациента оставалось стабильным, инфекционных эпизодов не было. Проводилась постепенная деэскалация антибактериальной терапии. Трансплантат не функционирует, проводились трансфузии тромбоконцентрата и эритроцитной массы.

Заключение: 29.04.2026 проведен консилиум по дальнейшей тактике ведения пациента. По результатам проведенного обследования, у пациента имеет место прогрессия основного заболевания на + 14 сутки после CAR-T- клеточной терапии.

Принимая во внимание объем проведенного лечения (химиотерапевтического, таргетной терапии, двух аллогенных ТГСК и CAR-T клеточной терапии), тяжелый соматический статус пациента и рефрактерность к проводимой комплексной терапии все возможные куративные опции на территории Российской Федерации в настоящий момент исчерпаны. В связи с отсутствием альтернативных методов лечения, решением консилиума состояние ребенка признано инкурабельным. Дальнейшая терапия может носить исключительно симптоматический характер, поддерживая жизнь и облегчая страдания больного.

Выписывается из отделения для продолжения наблюдения специалистами паллиативной службы по м/ж. Перед выпиской 02-03.05.26 выполнены трансфузии тромбоконцентрата и эр.взвеси.

Состояние на момент выписки: Клинический статус: Жалобы активно не предъявляет. Самочувствие не страдает. Не лихорадит. Кожные покровы бледно-розовые, чистые, умеренно влажные. Геморрагический синдром отсутствует. Слизистые оболочки ротовой полости розовые, чистые, влажные. Сердечно-легочная деятельность удовлетворительная. Тошноты, рвоты нет. Живот мягкий, доступен пальпации во всех отделах, безболезненный. Физиологические отправления в норму.

Рекомендации: Рекомендации:

1. Наблюдение терапевта/гематолога, специалистов паллиативной помощи по м/ж.
2. Контроль общего анализа крови с лейкоцитарной формулой и биохимического анализа крови (мочевина, креатинин, калий, натрий, АЛТ, АСТ, общий и прямой билирубин, глюкоза, кальций ионизированный) – 1 раз в неделю; при необходимости – чаще; забор анализов на дому.
3. При нарастании гепатоспленомегалии, лейкоцитоза в периферической крови рассмотреть вопрос о назначении меркаптопурина 50 мг/м² 1р/сут р.о, проведении курсов citarabина 75 - 200 мг/м², везицида 150- 200 мг/м² или циклофосфида 150 мг/м² на фоне приема аллопуринола 300 мг/сут и инфузионной терапии в составе 0,9% раствора NaCl/5% раствора глюкозы из расчета 2,5-3 л/м² с добавлением 5% соды (80 мл на каждые 1000 мл инфузии); под контролем диуреза и биохимического анализа крови (калий, натрий).

мочевина, креатинин, мочевая кислота).

4. С сдерживающей целью продолжить терапию ингибиторами FL/T3 (гилгеритиниб) по 40 мг 1 р/сут per os; возможно увеличение дозы до 120 мг per os. Таблетки у пациента на руках.

5. При появлении проявлений острой РТПХ (кожная сыпь 50% площади тела и более, постоянная рвота, диарейный синдром, нарастание уровня билирубина) – связаться с отделением ТПСК1; рассмотреть вопрос о назначении преднизолона в дозе 1 мг/кг/сут р.о.

6. При появлении болевого синдрома показано обезболивание:

- В случае появления болевого синдрома первой линией терапии служат НПВС. Можно применять ибупрофен в дозе 10 мг/кг х 4 р/д или парацетамол в дозе 15 мг/кг х 4 р/д (дозы для перорального приема).

- При неэффективности – назначение трамадола в дозе 2 мг/кг х 3 р/сут (в/в), при недостаточной эффективности повышение дозы до 2 мг/кг х 4 р/сут (per os) в сочетании с НПВС (максимальная суточная доза трамадола 8 мг/кг/сут).

- При неэффективности НПВС и трамадола назначение морфина п/к в стартовой дозе 0,1 мг/кг х 4 р/сут (строго каждые 6 часов), при необходимости повышение дозы до 0,1 мг/кг х 6 р/сут (строго каждые 4 часа). Доза при прорывных болях 10-30% от суточной дозы, вводится по требованию.

- Необходимая доза морфина пересчитывается ежедневно путем суммации базовой дозы и дозы, введенной на прорывные боли.

- При подборе необходимой дозы парентерального морфина возможен переход на трансдермальную систему с фентанилом или морфина пролонгированного действия в таблетках.

- Переход на морфин пролонгированного действия в таблетках (MST-continus): суточная доза, вводимая п/к, умножается на 3, полученная суточная доза дается за 2 приема. Так, если пациент получает 40 мг морфина в сутки подкожно, то суточная доза MST-continus составит $40 \times 3 = 120$ мг (60 мг х 2 р/д) р.о. Таблетки нельзя ломать!

- Переход на трансдермальную систему с фентанилом: 2-х ступенчатый перерасчет.

1. Необходимо перевести дозу подкожно вводимого морфина на дозу перорального морфина (умножить суточную дозу на 3). Так, если пациент получает 40 мг морфина в сутки подкожно, то суточная доза MST-continus составит $40 \times 3 = 120$ мг р.о.

2. Полученная доза перорального морфина делится на 3, что составит необходимую дозу (размер) пластыря. Если пациент получает 120 мг морфина р.о., то доза (размер) пластыря составит $120:3 = 40$ мкг/час. Доза округляется в большую сторону до имеющейся в наличии трансдермальной системы. В России доступны трансдермальные системы с дозой 25 мкг/час, 50 мкг/час, 75 мкг/час, 100 мкг/час. Трансдермальная система наклеивается на 72 часа, пластырь резать нельзя. В первые 18 часов после наклеивания 1-й трансдермальной системы продолжается плановое обезболивание морфином короткого действия.

- Дозы анальгетиков могут прогрессивно увеличиваться, зависят от потребностей ребенка и ограничены только жизнеугрожающими побочными эффектами препаратов!

- Применение промедола в случае хронического обезболивания у детей противопоказано в связи с нейротоксичностью его метаболитов!

7. В случае лихорадки, усиления болевого синдрома, появления признаков дыхательной недостаточности, кровотечения показана госпитализация в гематологическое/терапевтическое отделение по месту жительства.

8. Может нуждаться в заместительной терапии препаратами крови - фильтрованными (по возможности облученными) препаратами крови по показаниям (группа крови O(I)Rh(+): эритроцитная взвесь при снижении уровня гемоглобина 80 г/л, тромбоцитарный концентрат при снижении уровня тромбоцитов 20×10^9 /л).

10. При лейкопении (уровне лейкоцитов $1,5 \times 10^9$ /л) и/или нейтропении (уровне нейтрофилов $0,5 \times 10^9$ /л), если она не вызвана действием терапии основного заболевания – стимуляция лейкопоза препаратом G-CSF из расчета 5 мкг/кг п/к под контролем гематологического ответа!

11. В связи с сохраняющимся тяжелым вторичным иммунодефицитом после ТПСК при появлении инфекционных эпизодов пациент нуждается в осмотре терапевта или гематолога, немедленном назначении цефиксима из расчета 400 мг/сут; при неэффективности пероральных а/б - назначение системных а/б широкого спектра действия - в связи с сохраняющимся вторичным комбинированным иммунодефицитом пациенту показаны только в/в инъекции.

12. При появлении диарейного синдрома - добавление к терапии нифуроксазида 200 мг 3 р/сут р.о. и сорбентов; при отсутствии эффективности - обращение в стационар, контроль водного баланса и электролитов.

13. По жизненным показаниям показано продолжение терапии:

- Противовирусная терапия: валацикловир 500 мг 2 р/сут р.о.
- Профилактика пневмоцистной пневмонии: сульфаметоксазол + триметоприм 480 4 таб 3 р/нед р.о.
- Противогрибковая профилактика: флуконазол 300мг/сут р.о.

По жизненным показаниям рассмотреть вопрос об обеспечении пациента данными лекарственными средствами незамедлительно!!!

14. Пациент является носителем ЦВК типа Хикман. Отец пациента проинформирован о правилах ухода и возможных осложнениях! Работа с ЦВК должна осуществляться в асептических условиях! При работе с катетером не допустимо использование шприцов объемом менее 10 мл в связи с опасностью нарушения целостности стенок каналов! При подозрении на ЦВК – ассоциированную инфекцию – наблюдение в условиях круглосуточного стационара, незамедлительная терапия антибактериальными препаратами широкого спектра действия через периферический венозный доступ, удаление ЦВК! Пациенту необходимо обеспечение расходных материалов для работы с катетером – стерильные перчатки, стерильные салфетки, заглушки, гепарин, физ-раствор, шприцы 10 мл, антисептики.

В контакте с инфекционным больным: Не был

Доза облучения накопленная за текущую госпитализацию и предыдущие госпитализации (мЗв): 8,2123

Листок нетрудоспособности: В оформлении листка нетрудоспособности не нуждается.

Приложение № 1 к выписке "Проведенные обследования"

Лечащий врач:

Заведующий отделением:

Главный врач:



Дунайкина М.А.

Шелихова Л.Н.

Литвинов Д.В.

Пожалуйста, заполните анкету о вашем опыте нахождения в Центре. Это займет менее 10 минут и поможет улучшить нашу работу



наведите камеру смартфона на QR-код и перейдите по ссылке

Приложение к выписке из истории болезни № 2026/3098, 2026/3493, 2026/4452
Пациент БАРАХТЕПКО ЕГОР АНДРЕЕВИЧ

ПРОВЕДЕННЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Клинический анализ крови

Исследование	WBC		RBC		HGB		PLT		NEUT#	
Норма	4 - 9	6.05 - 9.85	4 - 5	4.2 - 4.6	115 - 138	130 - 160	180 - 320	204 - 356	1.5 - 8.5	2 - 5.5
Ед.	10 ⁹ /л	10 ⁹ /л	10 ¹² /л	10 ¹² /л	г/л	г/л	10 ⁹ /л	10 ⁹ /л	10 ⁹ /л	10 ⁹ /л
01.04		0.55		2.67	75			16		
02.04		0.62		3.11	87			16		
03.04		0.53		2.98	83			36		
04.04		0.58		2.79	81			28		
05.04		0.35		2.89	83			16		
06.04		0.05		2.93	81			33		
07.04		0.01		3.02	84			21		
08.04		0.01		2.81	78			14		
09.04		0.01		3.05	84			36		
10.04		0.01		3.06	86			24		
11.04		0.07		2.99	84			19		
12.04		0.05		3.01	85			38		
13.04		0.06		3.00	86			31		
14.04		0.11		2.95	82			19	0.00	
15.04		0.08		2.92	82			58		
16.04		0.10		2.85	79			42		
17.04		0.11		3.09	85			20		
18.04		0.11		2.91	83			35		
19.04		0.18		2.89	82			20		
20.04		0.17		2.80	80			33		
21.04		0.16		2.75	76			22		
22.04		0.28		3.05	85			17		
23.04		0.29		3.21	93			35	0.01	
24.04		0.41		3.06	86			25		
25.04		0.50	3.07			86		19		
26.04	0.71		2.91			82	26			
27.04	0.90		3.03			87	21			
28.04	1.23		3.03			85	40			0.06
29.04	1.68		2.92			85	28			0.15
30.04	2.16		2.90			83	19			0.23

Исследование	LYMPH		MONO#	EO#		BASO#
Норма	1.2 - 3	1.5 - 7	0.09 - 0.6	0.002 - 0.3	0.061 - 0.5	0 - 0.06
Ед.	10 ⁹ /л	10 ⁹ /л	10 ⁹ /л	10 ⁹ /л	10 ⁹ /л	10 ⁹ /л
01.04						
02.04						
03.04						
04.04						
05.04						
06.04						
07.04						
08.04						
09.04						
10.04						
11.04						
12.04						
13.04						

Исследование	LYMPH		MONO#	EO#		BASO#
Норма	1.2 - 3	1.5 - 7	0.09 - 0.6	0.002 - 0.3	0.061 - 0.5	0 - 0.06
Ед.	10 ⁹ /л	10 ⁹ /л	10 ⁹ /л	10 ⁹ /л	10 ⁹ /л	10 ⁹ /л
14.04		0.09	0.02		0.00	0.00
15.04						
16.04						
17.04						
18.04						
19.04						
20.04						
21.04						
22.04						
23.04		0.18	0.10		0.00	0.00
24.04						
25.04						
26.04						
27.04						
28.04	0.38		0.79	0.00		0.00
29.04	0.42		1.11	0.00		0.00
30.04	0.42		1.51	0.00		0.00

Лейкоцитарная формула

Исследование	Норма	Ед.	22.04	27.04
Лимфоциты	19 - 37	%	38.00	48.00
Моноциты	3 - 9.9	%	12.0	51.0
Сегментоядерные нейтрофилы	47 - 72	%		1.0

Биохимический анализ крови

Исследование	Норма	Ед.	01.04	02.04	03.04	04.04	05.04	06.04	07.04
АЛТ	0 - 37	Ед/л		22.2				12.8	
АСТ	0 - 39	Ед/л		40.2				29.6	
Альбумин	32 - 45	г/л		37				35	
Билирубин общ.	0 - 17	мкмоль/л		4.2				5.3	
Билирубин пр.	0 - 5	мкмоль/л		1.89				2.23	
Глюкоза	4.11 - 5.89	ммоль/л		5.52				4.85	
Калий	3.5 - 5.1	ммоль/л	4.11	3.9	4.1	4.2	4.0	3.5	3.7
Кальций ион.	1.12 - 1.32	ммоль/л	1.12	1.12				0.95	1
Креатинин	0 - 106	мкмоль/л	176.1	175.7	154.5			149.3	
ЛДГ	0 - 279	Ед/л		515					
Мочевина	2.9 - 7.5	ммоль/л	5.4	5.1	4.8			2.7	
Натрий	136 - 145	ммоль/л	139.7	139	145	146	145	144	143
СРБ	0 - 5	мг/л		6.1				7.6	
Магний	0.7 - 0.91	ммоль/л		0.77				0.62	0.75
Триглицериды	0 - 2.3	ммоль/л						1.37	
Фосфор	0.95 - 1.6	ммоль/л	1.0						
Цистатин С, массовая концентрация в сыворотке или плазме крови	0.62 - 1.11	мг/л	1.146	1.227				0.983	
Исследование	Норма	Ед.	08.04	09.04	10.04	11.04	12.04	13.04	14.04
АЛТ	0 - 37	Ед/л	9.7					121.1	
АСТ	0 - 39	Ед/л	26.0					109.3	
Альбумин	32 - 45	г/л	35					38	
Белок общий	60 - 80	г/л	56.9						
Билирубин общ.	0 - 17	мкмоль/л	5.2					6.6	
Билирубин пр.	0 - 5	мкмоль/л	2.15					2.98	
Глюкоза	4.11 - 5.89	ммоль/л	4.79					5.10	

Исследование	Норма	Ед.	08.04	09.04	10.04	11.04	12.04	13.04	14.04
Кальций	3.5 - 5.1	ммоль/л	3.8	3.4	3.8	3.9	3.7	4.2	4.4
Кальций ион.	1.12 - 1.32	ммоль/л	1.03	1.03				1.14	
Креатинин	0 - 106	мкмоль/л	129.1		118.9	109.3	100.0	105.9	
ЛДГ	0 - 279	Ед/л	486						
Мочевина	2.9 - 7.5	ммоль/л	4.2		3.69	4.11	4.48	4.63	
Натрий	136 - 145	ммоль/л	142	141	139	141	137.8	137	137
СРБ	0 - 5	мг/л	23.1						
Магний		ммоль/л	REPLACE D	Нет реагента					
	0.7 - 0.91	ммоль/л						0.73	
Цистатин С, массовая концентрация в сыворотке или плазме крови	0.62 - 1.11	мг/л	0.987					0.992	

Исследование	Норма	Ед.	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04
АЛТ	0 - 37	Ед/л		64.4		53.2	
АСТ	0 - 39	Ед/л		37.2		45.9	
Альбумин	32 - 45	г/л		38		35	
Белок общий	60 - 80	г/л		61.1			
Билирубин общ.	0 - 17	мкмоль/л		5.4		6.8	
Билирубин пр.	0 - 5	мкмоль/л		2.67		3.21	
Глюкоза	4.11 - 5.89	ммоль/л		5.80		5.68	
Кальций	3.5 - 5.1	ммоль/л	4.8	4.3		4.0	
Кальций ион.	1.12 - 1.32	ммоль/л		1.17		1.12	
Креатинин	0 - 106	мкмоль/л	100.7	92.0		80.3	
ЛДГ	0 - 279	Ед/л		324			
Мочевина	2.9 - 7.5	ммоль/л	5.57	5.69		3.99	
Натрий	136 - 145	ммоль/л	136	138		137	
СРБ	0 - 5	мг/л	46.0	63.1		102.4	
Магний	0.7 - 0.91	ммоль/л		0.74		0.74	
Ферритин	15 - 200	мкг/л	6850.1		5941.7		7724.5

Исследование	Норма	Ед.	22.04	23.04	25.04	27.04	29.04
АЛТ	0 - 37	Ед/л		106.5			
	0 - 41	Ед/л				183.7	168.0
АСТ	0 - 39	Ед/л		135.0			
	0 - 40	Ед/л				136.7	136.6
Альбумин	32 - 45	г/л		38.8		37.3	36.7
Белок общий	60 - 80	г/л		60.99		58.44	56.53
Билирубин общ.	0 - 17	мкмоль/л		7.57		15.22	21.94
Билирубин пр.	0 - 5	мкмоль/л		5.18		11.63	18.79
Глюкоза	4.11 - 5.89	ммоль/л		5.67		5.48	5.59
Кальций	3.5 - 5.1	ммоль/л	4.38	4.1	4.1	4.12	3.9
Кальций ион.	1.12 - 1.32	ммоль/л	1.11	1.19		1.16	1.17
Креатинин	0 - 106	мкмоль/л		69.5			62.6
ЛДГ	0 - 225	Ед/л				536.0	573.7
	0 - 279	Ед/л		562.3			
Мочевина	2.9 - 7.5	ммоль/л		3.30		3.32	2.81
Натрий	136 - 145	ммоль/л	138.6	137	137	139	135
СРБ	0 - 5	мг/л		61.56		33.2	31.4
Магний	0.7 - 0.91	ммоль/л	0.81	0.86		0.83	0.90
Ферритин	20 - 250	мкг/л				8304.2	7268.9

Общий анализ мочи

Исследование	Норма	Ед.	02.04	08.04
Бактерии (осадок)	0 - 0		30	30

Исследование	Норма	Ед.	02.04	08.04
Белок	0 - 0.1	г/л	не обнаружено	не обнаружено
Билирубин	0 - 0	ммоль/л	не обнаружено	не обнаружено
Глюкоза	0 - 0	ммоль/л	в норме	в норме
Дрожжи (осадок)	0 - 0	п/з	не обнаружено	не обнаружено
Кетоны	0 - 0	ммоль/л	не обнаружено	не обнаружено
Кристаллы (осадок)		п/з		не обнаружено
	0 - 0	п/з	не обнаружено	
Круглый эпителий (осадок)	0 - 0.5	п/з	не обнаружено	не обнаружено
Лейкоциты	0 - 0	в мкл	не обнаружено	не обнаружено
Лейкоциты (осадок)	0 - 3	п/з	1.80	1.80
Нитриты	0 - 0	качеств.	не обнаружено	не обнаружено
Относительная плотность	1.012 - 1.025		1.007	1.010
Патологические цилиндры (осадок)	0 - 0	п/з	не обнаружено	не обнаружено
Плоский эпителий (осадок)	0 - 2	п/з	не обнаружено	не обнаружено
Прозрачность	0 - 0		Прозрачная	Прозрачная
Слизь (осадок)	0 - 0		не обнаружено	не обнаружено
Сперматозоиды (осадок)	0 - 0	п/з	отсутствует	-
Уробилиноген	0 - 0	ммоль/л	в норме	в норме
Цвет	0 - 0		Светло-желтая	Светло-желтая
Цилиндры гиалиновые (осадок)	0 - 0.1	п/з	не обнаружено	не обнаружено
Эритроциты	0 - 0	в мкл	не обнаружено	не обнаружено
Эритроциты (осадок)	0 - 2	в пз	0.80	1.00
pH	5.5 - 7		7	8

Биохимический анализ мочи

Исследование	Норма	Ед.	02.04
Креатинин (Суточная)	8.84 - 13.3	ммоль/сут	-
Креатинин мочи(разовый)	3460 - 22900	мкмоль/л	2814.00

Инфекционный статус

ПЦР венозной крови

Исследование	06.04	06.04	08.04	13.04	13.04	20.04	20.04	27.04
PCR-Adenovirus		ОТР			ОТР		ОТР	
PCR-BK virus		18	ОТР					
PCR-CMV(K)	ОТР			ОТР		ОТР		ОТР
PCR-EBV(K)	ОТР			ОТР		ОТР		ОТР
PCR-HHV - VI типа (K)	ОТР			ОТР		ОТР		ОТР

Исследование	27.04
PCR-Adenovirus	ОТР
PCR-BK virus	
PCR-CMV(K)	
PCR-EBV(K)	
PCR-HHV - VI типа (K)	

ПЦР жидкости БАЛ

Исследование	01.04	01.04
PCR-Chlamydomydia pneumoniae	ОТР	
PCR-Mycobacterium tuberculosis complex (MTC)		ОТР
PCR-Mycoplasma pneumoniae	ОТР	
PCR-Pneumocystis		ОТР

Исследование	01.04	01.04
Выявление вируса гриппа А/В методом ПЦР		ОТР

Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность (Кровь Аэробы) от 19.04.2026:

Микроорганизмы не обнаружены (MN)

Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность (Кровь Аэробы) от 20.04.2026:

Микроорганизмы не обнаружены (MN)

Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность (Кровь Аэробы) от 21.04.2026:

Микроорганизмы не обнаружены (MN)

Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность (Кровь Аэробы) от 22.04.2026:

Микроорганизмы не обнаружены (MN)

Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность (Кровь Аэробы) от 23.04.2026:

Микроорганизмы не обнаружены (MN)

Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность (Кровь Аэробы) от 27.04.2026:

Микроорганизмы не обнаружены (MN)

Микроорганизмы не обнаружены (MN)

Микробиологическое (культуральное) исследование мазка с поверхности кожи (Мазок с кожи) от 03.04.2026:

Staphylococcus haemolyticus (STFHAEM) 10*3 КОЕ/мл

Микробиологическое (культуральное) исследование в биологическом материале на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (Мазок/отделяемое из правого уха) от 06.04.2026:

Микроорганизмы не обнаружены (MN)

Инструментальные исследования

УЗИ органов брюшной полости от 02.04.2026

Заключение: Эхо-признаки диффузных изменений паренхимы почек.

Ультразвуковое исследование органов мошонки (с доплерографией) от 28.04.2026

Заключение: УЗ признаки двустороннего гидроцеле. Образования мягких тканей паховой области справа.

Эхокардиография от 31.03.2026

Рост, см: 186.5 Вес, кг: 59.6 ППТ, м2: 1.74 ЧСС: 82 КДР ЛЖ, мм: 57.8 Z-SCORE: 1.8 КДО ЛЖ, мл: 165.2 iКДО ЛЖ, мл: 94.9 КСР ЛЖ, мм: 40.3 ФВ, %: 56.9 КСО ЛЖ, мл: 71.3 МЖП, мм: 8.7 Z-SCORE: 0.5 ЗСЛЖ, мм: 8.2 Z-SCORE: 0.6 ИММЛЖ (г/м2,7): 34.71 КДО ЛЖ, мл: 121 Z-SCORE: 0.7 iКДО ЛЖ, мл: 69.5 КСО ЛЖ, мл: 52 УО, мл: 69.0 ФВ, %: 57.0 D восх. ОА, мм: 26 Z-SCORE: 0.4 D перепейки аорты, мм: 14 Z-SCORE: -0.1 S левого предсердия, см2: 14.5 Z-SCORE: -0.1 S правого желудочка, см2: 22 Z-SCORE: 0.7 Легочная артерия (ствол), мм: 29 Z-SCORE: 1.4 S правого предсердия, см2: 15 Z-SCORE: -0.2 Аорт.кл. Vmax, м/с: 0.74 Пик.гр, mmHg: 2.2 Пик.гр. на перепейке аорты, mmHg: 8 Митр.клапан V(E), м/с: 0.7 Пик.гр, mmHg: 2.0 Кл.лег.арт. Vmax, м/с: 0.95 Пик.гр, mmHg: 3.6 Трикусп.клапан V(E), м/с: 0.5 Пик.гр, mmHg: 1.0 Пик.гр. регургитации, mmHg: 12 ЦВД: 5 СДЛА: 17.0 D НПВ фактический: 19 D max НПВ расчетный: 23.3

Компьютерная томография органов грудной полости (мультиспиральная) от 15.04.2026

Описание: Выполнено в динамике с КТ-данными от 23-03-2026 Дистальный конец ЦВК в ВПВ. В динамике отмечается уменьшение объема и плотности ранее выявляемых очаговых и инфильтративных изменений билатерально с сохранением малого уплотнения интерстиция. На данном фоне сохраняются периваскулярные очаги С1 справа до 2,5мм и до 5мм без динамики размеров. Иных "свежих" очаговых и инфильтративных изменений в легких не выявлено. Трахея и крупные бронхи проходимы, просветы их не деформированы, стенки не изменены. Малое содержимое субсегментарных бронхов. Жидкости в плевральных полостях и полости перикарда нет. Средостение расположено по средней линии, не расширено. Вилочковая железа типично расположена, однородной структуры. В средостении определяются единичные не увеличенные лимфатические узлы. В подмышечных областях визуализируются немногочисленные лимфатические узлы размерами от 3 до 7мм. На исследованном

уровне участков патологической плотности и деструкции в костях не выявлено.

Заключение: Неполное разрыхление воспалительных изменений легких билатерально. Стабильные очаги С1 справа.

Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа (мультиспиральная) от 16.04.2026

Описание: Пневматизация лобной пазухи не нарушена, слизистая оболочка не утолщена.

Верхнечелюстные пазухи симметричны, пневматизированы с обеих сторон, слизистая оболочка их неравномерно циркулярно, полиповидно утолщена до 10-11 мм. Основная пазуха развита нормально, пневматизирована, слизистая оболочка неравномерно утолщена до 5 мм. Ячейки решетчатой кости пневматизированы, немногочисленные ячейки с утолщенной слизистой оболочкой. Пергородка носа по средней линии. Слизистая оболочка носовых раковин не утолщена. Костные стенки придаточных пазух носа прослеживаются на всем протяжении, достоверных данных за их деструкцию не получено. Справа. Сосцевидный отросток имеет умеренно развитую ячейковую систему, многочисленные ячейки с нарушенной пневматизацией. Антрум обычных размеров, в просвете патологическое содержимое. Костная часть наружного слухового прохода сформирована правильно, просвет его обычной ширины. Наружный слуховой проход свободный. Барабанная перепонка без особенностей. Барабанная полость обычных размеров, пневматизация её не нарушена. Изменений в строении цепи слуховых косточек не выявлено. Структуры внутреннего уха и внутренний слуховой проход не изменены. Достоверных признаков деструкции элементов височной кости не выявлено. Канал лицевого нерва расположен типично, не расширен. Крупные сосуды без особенностей. Слева. Сосцевидный отросток имеет умеренно развитую ячейковую систему, многочисленные ячейки с нарушенной пневматизацией. Антрум обычных размеров, пневматизирован. Костная часть наружного слухового прохода сформирована правильно, просвет его обычной ширины. Наружный слуховой проход свободный. Барабанная перепонка без особенностей. Барабанная полость обычных размеров, пневматизация её не нарушена. Изменений в строении цепи слуховых косточек не выявлено. Структуры внутреннего уха и внутренний слуховой проход не изменены. Достоверных признаков деструкции элементов височной кости не выявлено. Канал лицевого нерва расположен типично, не расширен. Крупные сосуды без особенностей.

Заключение: Пневматизация околоносовых пазух на фоне утолщенной слизистой оболочки значимо не нарушена. Патологическое содержимое в многочисленных ячейках сосцевидных отростков с обеих сторон, пневматизация барабанных полостей билатерально не нарушена.

Компьютерная томография височной кости (мультиспиральная) от 16.04.2026

Описание: Описано единым протоколом в исследовании №46463095

Заключение: Описано единым протоколом в исследовании №46463095

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных от 01.04.2026

Заключение: Запись отведения V1 не проводилась. Нормальное положение ЭОС. Слабая синусовая аритмия с ЧСС 75-83 уд/мин. Пограничное увеличение продолжительности интервала QTc до 0,46 сек.

Регистрация электрокардиограммы от 01.04.2026

Описание: исследование выполнено

Заключение: см. расшифровку ЭКГ

Электроэнцефалография бодрствования до 30 минут от 10.04.2026

Описание: Регистрация ЭЭГ пассивного бодрствования с проведением функциональных проб.

Заключение: ЭЭГ содержит большое количество физических артефактов. Запись не валидна, интерпретации не подлежит.

Электроэнцефалография бодрствования до 30 минут от 15.04.2026

Описание: Запись ЭЭГ в состоянии пассивного бодрствования и в начальных стадиях NR-сна. ЭЭГ бодрствования организована по возрасту. Основной корковый альфа-ритм достаточного индекса возрастной частоты (10 Гц), достаточной амплитуды (30 - 70 мкВ), с правильным зональным

распределением, слабо модулированный. В лобно-центральных отделах регистрируется фрагментарный сенсомоторный мю-ритм с частотой 10 Гц, амплитудой до 50 мкВ. Медленные волны преимущественно тета-диапазона низкого индекса регистрируются в виде диффузных волн, амплитудой не выше фона, с преобладанием по передним областям. Бета-активность низкого индекса регистрируется диффузно, амплитудой не более 25 мкВ. Реакция активации выражена достаточно. При РФС реакция усвоения ритма не прослеживается. Реакция на ГВ-пробу, после окончания пробы происходит быстрое восстановление исходной ритмики (в течение 10 сек). При засыпании отмечается дезорганизация ритмики, фрагментация и редукция основных корковых ритмов, нарастание индекса медленных волн и бета-активности с последующим появлением заостренных бифазных потенциалов с преобладанием в лобно-центральной вертексной зоне ("вертекс-потенциалы"). Более глубокие стадии сна не достигнуты. Продукция физиологических паттернов сна в начальной стадии NR-сна достаточная.
Заключение: ЭЭГ бодрствования и начальных стадий физиологического сна - вариант возрастной нормы. Типичной эпилептиформной активности в записи нет. Синхронный видеофайл без особенностей.

Электрэнцефалография бодрствования до 30 минут от 21.04.2026

Описание: Запись ЭЭГ в состоянии пассивного бодрствования. ЭЭГ бодрствования организована по возрасту. Основной корковый альфа-ритм достаточного индекса возрастной частоты (10 - 11 Гц), достаточной амплитуды (30 - 70 мкВ), с правильным зональным распределением, слабо модулированный. В лобно-центральных отделах регистрируется фрагментарный сенсомоторный мю-ритм с частотой 10 - 11 Гц, амплитудой до 50 мкВ. Медленные волны тета-диапазона низкого индекса регистрируются в виде диффузных волн, амплитудой не выше фона, с преобладанием по передним областям. Бета-активность низкого индекса регистрируется диффузно, амплитудой не более 25 мкВ. Реакция активации выражена достаточно. При РФС реакция усвоения ритма не прослеживается. Реакция на ГВ-пробу, после окончания пробы происходит быстрое восстановление исходной ритмики (в течение 10 сек).
Заключение: ЭЭГ бодрствования - вариант возрастной нормы. Типичной эпилептиформной активности в записи нет. Синхронный видеофайл без особенностей.

Консультации специалистов

Осмотр невролога (Хомякова С.И.) от 01.04.2026

Заключение: Вторичный нервно-мышечный синдром. лекарственная нейропатия.

Осмотр отоларинголога (Верещагина О.И.) от 02.04.2026

Заключение: Острый затяжной риносинусит.

Острый правосторонний средний отит, перфоративная стадия.

Левосторонний экссудативный средний отит.

Рекомендации: 1) КТ ОНП и височных костей;

2) Избегать попадания воды в правое ухо;

3) Туалет правого наружного слухового прохода в условиях ЛОР-кабинета;

4) Сложные капли (Диоксидин 5 мл + NaCl 0,9% 5 мл) по 4-5 капель в правый наружный слуховой проход 2-3 раза в день;

5) Сложные капли (Диоксидин 5 мл + Физ. рас-р 5 мл + Тизин 2 мл) по 2-3 капли в каждую половину полости носа 3-4 раза в день;

6) Динамическое наблюдение ЛОР-врача.

Осмотр нефролога (Аксенова М.Е.) от 03.04.2026

Заключение: Острое повреждение почек 1-2 ст (30.03.2026).

рСКФ (CKiDU25) = 55,6 мл/мин/1.73 м².

Аорто-мезентериальный конфликт слева (сдавление левой почечной вены).

Рекомендации: -ЛДГ, гаптоглобин, пшисциты крови

-контроль АД, диуреза

-контроль СРБ, креатинина, цистатина С, электролитов крови в динамике

-адекватный питьевой режим, ИТ (не менее 1л/м²/сут + потери)

-наблюдение в динамике

Осмотр отоларинголога (Верещагина О.И.) от 03.04.2026

Заключение: Острый затяжной риносинусит.

Острый правосторонний средний отит, репаративная стадия?

Правосторонний наружный отит?

Левосторонний экссудативный средний отит.

Рекомендации: 1) КТ ОНП и височных костей;
2) Избегать попадания воды в правое ухо;
3) Сложные капли (Диоксидин 5 мл+NaCl 0,9% 5 мл) по 4-5 капель в правый наружный слуховой проход 2-3 раза в день;
4) Сложные капли (Диоксидин 5 мл + Физ. рас-р 5 мл + Тизин 2 мл) по 2-3 капли в каждую половину полости носа 3-4 раза в день;
5) Микробиологическое исследование мазка из правого слухового прохода на бактериальные и грибковые возбудители;
6) Динамическое наблюдение ЛОР-врача.

Осмотр отоларинголога (Верещагина О.И.) от 09.04.2026

Заключение: Острый затяжной риносинусит, клиническое улучшение.

Острый правосторонний средний отит, репаративная стадия.

Левосторонний экссудативный средний отит.

Рекомендации: 1) КТ ОНП и височных костей;

2) Избегать попадания воды в правое ухо;

3) Сложные капли (Диоксидин 5 мл+NaCl 0,9% 5 мл) по 4-5 капель в правый наружный слуховой проход 2-3 раза в день;

4) Динамическое наблюдение ЛОР-врача.

Осмотр офтальмолога (Мишанина В.А.) от 14.04.2026

Заключение: преретинальные кровоизлияния на обоих глазах

Рекомендации: по согласованию с лечащим врачом - с/к инъекции препарата "гемаза" на обоих глазах
плановое наблюдение офтальмолога

Осмотр отоларинголога (Тимофеева О.К.) от 22.04.2026

Заключение: Острый затяжной риносинусит, выздоровление.

Острый правосторонний средний отит, выздоровление

Левосторонний экссудативный средний отит, выздоровление.

Рекомендации: Динамическое наблюдение ЛОР-врача.

Осмотр офтальмолога (Мишанина В.А.) от 22.04.2026

Заключение: преретинальные кровоизлияния на обоих глазах

Рекомендации: по согласованию с лечащим врачом - с/к инъекции препарата "гемаза" на обоих глазах
плановое наблюдение офтальмолога

Лечащий врач ДУНАЙКИНА Мария Алексеевна

